



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA
TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT (PKBRS)
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Program Kerja Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) Rumah Sakit Prima Husada Malang dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Program Kerja Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit Prima (PKBRS) ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Program Kerja Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit Prima (PKBRS) ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 01 Januari 2026
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada

dr. Resti Lestantini,M.Kes

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISIiv

BAB I PENDAHULUAN.....5

1.1 Latar Belakang.....5

1.2 Dasar Hukum6

1.3 Maksud Dan Tujuan6

BAB II GAMBARAN UMUM7

2.1 Visi7

2.2 Misi.....7

2.3 Falsafah7

2.4 Motto.....7

2.5 7 Nilai Budi Utama.....7

2.6 SOTK.....8

BAB III KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN9

3.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiata9

3.2 Sasaran10

3.3 Cara Melaksanakan Kegiatan12

3.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026.....14

3.5 Kebutuhan Anggaran.....17

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI.....18

BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN20

5.1 Pencatatan.....20

5.2 Laporan20

BAB VI PENUTUP21



BAB I

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 78, Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan Pelayanan KB yang aman, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009, pasal 1 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Dalam rangka penguatan dan pencapaian tujuan pelayanan KB, maka dukungan manajemen pelayanan KB menjadi sangat penting, mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, sampai dengan Pemantauan dan Evaluasi. Dalam program KB ini, terdapat dua kementerian/lembaga yang memegang peranan penting yaitu Kementerian Kesehatan dan BKKBN. Koordinasi yang baik dan berkesinambungan antara BKKBN dan Kementerian Kesehatan beserta jajaran di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam manajemen pelayanan KB menjadi hal yang sangat penting. Dengan manajemen pelayanan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*), penerimaan (*acceptability*) dan kualitas pelayanan (*quality*).

1.1 Latar Belakang

Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS) merupakan bagian dari program keluarga berencana (KB), yang sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan percepatan penurunan stunting. Kunci keberhasilan PKBRS adalah ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi serta manajemen yang handal. Rumah sakit dalam melaksanakan PKBRS sesuai dengan pedoman pelayanan KB yang berlaku, dengan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan KB secara terpadu dan paripurna.
2. Mengembangkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan KB dan meningkatkan kualitas pelayanan KB.
3. Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan PKBRS termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
4. Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan pembinaan teknis dalam melaksanakan PKBRS.
5. Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan KB bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya.
6. Melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKBRS.
7. Adanya regulasi rumah sakit yang menjamin pelaksanaan PKBRS, meliputi SPO pelayanan KB per metode kontrasepsi termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
8. Upaya peningkatan PKBRS masuk dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja anggaran (RKA) rumah sakit.
9. Tersedia ruang pelayanan yang memenuhi persyaratan untuk PKBRS antara lain ruang konseling dan ruang pelayanan KB.



10. Pembentukan tim PKBR serta program kerja dan bukti pelaksanaannya.
11. Terselenggara kegiatan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan pelayanan PKBRs, termasuk KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
12. Pelaksanaan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit : Menjadi landasan dasar yang mengatur fungsi, tugas, hak, kewajiban, dan penyelenggaraan rumah sakit secara umum.
2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan : Undang-undang ini merevolusi sistem kesehatan, mengubah fokus dari kuratif (pengobatan) ke preventif (pencegahan) dan pelayanan primer (Puskesmas, klinik), yang berdampak besar pada rumah sakit dalam sistem rujukan dan integrasi layanan kesehatan secara keseluruhan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
6. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 192.1/I-KEP/DIR/IV/2021 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

1.3 Maksud Dan Tujuan

- a. Tujuan Umum
Rumah sakit melaksanakan Pelayanan KB sesuai dengan pedoman Pelayanan KB Rumah Sakit
- b. Tujuan Khusus
 - 1) Ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB.
 - 2) Ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB.
 - 3) Ketersediaan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB.
 - 4) Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP.
 - 5) Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
 - 6) Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi : “ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

2.2 Misi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :

1. Memberi pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

2.3 Falsafah

Memberikan pelayanan secara professional berlandaskan hati nurani yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.

2.4 Motto

Motto RS Prima Husada : “Sahabat Menuju Sehat”

2.5 7 Nilai Budi Utama

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.6 SOTK





BAB III

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiata

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB.	Tersedianya semua jenis alat dan Obat kontrasepsi meliputi : a. KB MOW b. KB IUD c. KB Implant d. KB Pil e. KB Suntik 3 Bulan f. KB Kondom
2	Ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB.	Tersedianya Poli Kesehatan Ibu dan Anak Tersedianya Poli Obstetri dan Ginekologi Tersedianya Ruang Operasi 24 jam
3	Ketersediaan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB	Adanya Tim PKBRS
4	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP.	Capaian Indikator Mutu Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit
5	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.	
6	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.	
7	Rapat koordinasi dengan pimpinan Rumah Sakit	• Ketersediaan anggaran program Tim PKBRS (pelatihan sosialisasi , fasilitas, APD) • Bukti laporan pelaksanaan program Tim PKBRS : direktur, kepala bidang, divisi, kepala unit pelayanan , ketua anggota Tim PKBRS



3.2 Sasaran

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/STANDAR D	INDIKATOR KEBERHASILAN	ALAT PENGUKUR
1.	Ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB	Memantau dan mengevaluasi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	Stok alat kontrasepsi tersedia di RS : a. KB MOW b. KB IUD c. KB Implant d. KB Pil e. KB Suntik 3 bulan f. KB Kondom	supervisi	100 %	Kebutuhan terpenuhi	Register pasien Dokumen
2.	Ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB.	Menyediakan sarana pelayanan	a. Tersedianya Poli Kesehatan Ibu dan Anak b. Tersedianya Poli Obstetri dan Ginekologi c. Tersedianya Ruang Operasi 24 jam	Supervisi	100 %	Sarana dan alat penunjang terpenuhi	Dokumen
3.	Ketersediaan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB	Terdapat tim pelaksana yang mempunyai kompetensi dibidang KB	Adanya Tim PKBRS	Supervisi	100 %	Tim memiliki STR dan SIP sesuai bidangnya	Dokumen
4.	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka		a. Ibu Nifas pasca salin b. Ibu Nifas pasca keguguran c. bu usia subur dengan pembatasan		100 %		a. Register pasien b. Dokumen



	Panjang (MKJP) dan Non MKJP.		atau penundaan kehamilan				
5.	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.		a. Ibu Nifas pasca salin b. Ibu Nifas pasca keguguran c. ibu usia subur dengan pembatasan atau penundaan kehamilan		100 %		a. Register pasien b. Dokumen
6	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.		a. Ibu Nifas pasca salin b. Ibu Nifas pasca keguguran c. Ibu usia subur dengan pembatasan atau penundaan kehamilan				a. Register pasien b. Dokumen
7	Rapat koordinasi dengan pimpinan Rumah Sakit		a. Tim PKBRS b. Direktur RS		100 %		Dokumen

3.3 Cara Melaksanakan Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1	KB pasca salin	Pemasangan IUD Pasca plasenta dan MOW	Sesuai SOP	-	24 Jam	Dokumen	
2	KB pasca keguguran	Pemasangan IUD setelah keguguran	Sesuai SOP	-	24 Jam	Dokumen	
3	Konsultasi dan pelayanan KB oleh bidan	Edukasi dan pelayanan KB	Sesuai SOP	Buku ABPK	Senin-jumat pukul 11.00-13.00	Dokumen dan Dokumentasi	
4	Rapat Tim	Diskusi dengan ketua tim dan anggota	diskusi		3 bulan sekali	Dokumentasi	
5	Sosialisasi atau penyuluhan	Penyuluhan bisa dilakukan diruang tunggu poli anak dan poli kandungan	Leaflet dan ceramah	leaflet	1 bulan sekali	Dokumentasi	



RUMAH SAKIT

PRIMA HUSADA

KONSULTASI & LAYANAN KB

RS PRIMA HUSADA MALANG

POLI KIA LT 2

senin-jumat jam 11.00-13.00



MELAYANI:

- ✓ IUD BKKBN (IUD COPPER - T)
- ✓ KB PIL
- ✓ KB SUNTIK 3 BULAN
- ✓ KONDOM
- ✓ IMPLAN

SYARAT AKSEPTOR IUD:

- Pastikan tidak sedang hamil
- IUD dipasang pada saat haid hari ke 2-5
- Tidak ada nyeri haid
- Setelah melahirkan normal / tidak operasi Caesar

SYARAT ADMINISTRATIF:

- Fotokopi KTP suami & istri masing - masing 1 lembar
- Fotokopi KK 1 lembar
- KK suami dan istri jadi 1

CONTACT PERSON:

0896-0696-2515

"Sahabat Menuju Sehat"

(0341) 458679 | 08113492244

Jl. Banjarum Selatan 3-9 Mondoroko Singosari-Malang

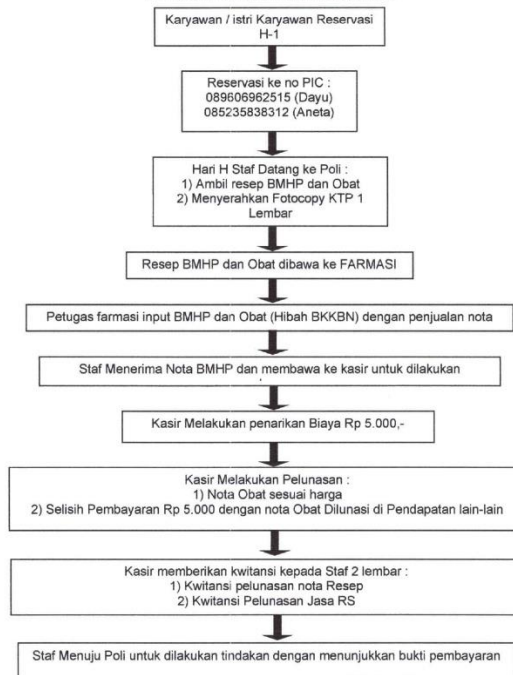
rs-primahusada.com




@rsprimahusada_malang



ALUR PELAYANAN KB BAGI KARYAWAN DAN ISTRI KARYAWAN
BERDASARKAN SE2052/I-SE/DIR/XI/2022



Malang, 18 November 2022
Direktur Rumah Sakit Prima Husada


dr. Ekowati S.K.P., MMRS

3.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026

NO .	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEM PAT	PIC	SUM BER DAN A	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB.	Stok alat kontrasepsi tersedia di RS : a. KB MOW b. KB IUD c. KB Implant d. KB Pil e. KB Suntik 3 bulan f. KB Kondom													Farmasi	Kepala ruang instalasi farmasi berkolaborasi dengan PJ KB	a.BK KBN b. Pengadaan PT	
2	Ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB.	a. Tersedianya klinik pelayanan KB b. Tersedianya Ruang Operasi 24 jam													Poliobgin Materitas Ruang IKO	Kepala ruang masin g-masin g	PT	
3	Ketersediaan tenaga	Adanya Tim PKBRS													Poliobgin	Kepala	PT	

	kesehatan yang memberikan pelayanan KB															Mater nitas Ruang IKO	ruang masin g-masin g		
4	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP.	a. Ibu Nifas pasca salin dan pasca keguguran , b. Ibu usia subur dengan pembatasan atau penundaan kehamilan														Poli obgin Mater nitas Ruang IKO	Kepal a ruang masin g-masin g	BKK BN dan PT	
5	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.	a. Ibu Nifas pasca salin dan pasca keguguran , b. Ibu usia subur dengan pembatasan atau penundaan kehamilan														Poli obgin Mater nitas Ruang IKO	Kepal a ruang masin g-masin g	BKK BN dan PT	



6	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.	a. ibu pasca salin b.ibu pasca keguguran																Poli obgin Mater nitas Ruan g IKO	Kepal a ruang masin g- masin g	-	
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--------------------------------	---	--

3.5 Kebutuhan Anggaran

Semua anggaran akan dibiayai dari anggaran RSPH Malang yang telah disetujui oleh PT.DPM

	BAHAN	RATA /BL	KEBUTUHAN 1 TH	HARGA SATUAN	TOTAL Rp
1	Lain-lain		2 goodie bag/bulan	Rp 20.000,-	Rp 480.000,-
2	Bed gynecologi		1	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-
3	Lampu sorot		1	Rp 1.250.000,-	Rp 1.250.000,-
4	IUD set		2	Rp 1.750.000,-	Rp 3.500.000,-
5	Meja kantor		1	Rp 1.100.000,-	Rp 1.100.000,-
6	Kursi kantor		1	Rp 999.000,-	Rp 999.000,-
7	Kursi pasien		2	Rp 899.000,-	Rp 899.000,-
TOTAL					Rp 13.588.000,-

Kebutuhan biaya pengembangan SDM RSPH Malang Tahun 2026

NO	Kegiatan /rincian kegiatan	Internal eksternal	Jumlah (satuan)	HARGA SATUAN	TOTAL Rp
1	Pelatihan CTU	Eksternal	1	-	Rp 4.000.000,-
2	Pelatihan KB/fee pemateri	Internal	1	-	Rp 250.000,-
3	Pelatihan KB/Konsumsi pemateri	Internal	1	-	Rp 25.000,-
4	Pelatihan KB/konsumsi peserta(snack)	Internal	34	Rp 5.000,-	Rp 170.000,-
5	Pelatihan KB/Konsumsi peserta (air mineral)	Internal	34	Rp 2.000,-	Rp 64.000,-
6	Cetak sertifikat	Internal	34	-	-
TOTAL					Rp 4.509.000,-



BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Skedul (jadwal) kegiatan tersebut akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali melalui rapat TIM PKBRS, bila dari evaluasi diketahui ada pergeseran/penyimpangan jadwal dapat segera diperbaiki sehingga tidak mengganggu program secara keseluruhan. Evaluasi skedul (jadwal) kegiatan tersebut dilakukan oleh ketua Tim PKBRS

Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan mencakup bagaimana laporan tersebut dibuat, oleh siapa dan kapan laporan tersebut dibuat serta ditujukan kepada siapa laporan tersebut.

Monitoring dengan melakukan Supervisi

SUPERVISI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT

TANGGAL/BULAN :

R.LINGKUP	INDIKATOR	PENILAIAN	R.TINDAK LANJUT	TTD YANG DISUPERVISI
Administrasi	- o Pelaksanaan pelayanan administrasi PKBRS sesuai regulasi - o Kelengkapan RM terkait KB	- o Ya - o Tidak - o Patuh - o Tidak		
Alat kontrasepsi	- o IUD Nova T - o IUD BKKBN - o Suntik - o Pil - o Implant - o Kondom			
Sarana		- o Layak - o Tidak		
Kendali mutu	o Program mutu internal pada tim PKBRS berjalan			
Pengetahuan staf tentang kie KB		- o Tahu - o Tidak tahu		
Keterampilan petugas		- o Bisa - o Tidak		
Kesimpulan				
Tanda tangan ketua tim dan kepala ruangan IRJA dan Supervisor	dr.Humaira,Sp.Og			
Saran				



Rekapitulasi hasil Supervisi selama 1 bulan dilakukan evaluasi dalam bentuk rapat unit /Rapat

Sesuai standard dan tidak sesuai standard diisi jumlah hasil rekapan sebulan dan diberi (%)

N O	Aspek yang di supervisi	Standar d /Target	Jml Sesuai Standar	Jumlah Tidak sesuai standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC
1	Alat kontrasepsi	terpenuhi	15	5	Kebutuhan alat kontrasepsi terpenuhi	Pengajuan ke BKKBN dan pengadaan saat stok minimal	Farmasi Pj KB
2	Sarana	Layak pakai	0	0	Sarana dan prasarana layak pakai	Kalibrasi 1 tahun sekali	IPSRS
3	Kendali mutu internal	tercapai	0	0	Mutu tercapai	Evaluasi setiap bulan	Kepala ruang maternitas dan PJ KB
4	Pengetahuan staf tentang kie KB	tahu	0	0	-	Dilakukan pelatihan internal satu tahun sekali.	Kepala ruang maternitas dan PJ KB
5	Keterampilan petugas	mampu	0	0	Sesuai SOP	Dilakukan pelatihan internal satu tahun sekali.	Kepala ruang maternitas dan PJ KB



BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

5.1 Pencatatan

Semua kegiatan Pelayanan KB dicatat sesuai jenis kegiatan dan SPO nya

5.2 Laporan

a. Laporan bulanan

Laporan dibuat setiap bulan untuk pelaporan kegiatan pelayanan, mutu serta jumlah stok alat kontrasepsi

b. Laporan Triwulan dibuat dengan merekap hasil kinerja selama 3 bulan

c. Laporan Tahunan

Dibuat 1 tahun sekali pada akhir tahun dan diserahkan pada awal januari tahun berikutnya



BAB VI

PENUTUP

Pelayanan keluarga berencana Rumah sakit adalah bagian pelayanan dari Rumah Sakit Prima Husada yang memberikan pelayanan dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien. Dengan adanya pedoman pelayanan keluarga berencana rumah sakit diharapkan dapat membantu dalam memberikan pelayanan khususnya tim PKBRS dan dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi seluruh staf rumah sakit terutama PPA dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Sehingga asuhan pelayanan pasien dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan yang berdampak terhadap peningkatan jumlah kunjungan pasien karena kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit Prima Husada.

Mengetahui,
Kepala Instalasi Rawat Jalan

dr. Dwi Nurwulan Pravitasari,
Sp.DVE FINS DV

Malang 31 Januari 2026
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes

